

OPERATIVA, CAPTACIÓN Y AGENDA PARA CLÍNICAS DE SALUD

Las 6 fugas de una *clínica de salud*.

Auditoría operativa de los 6 puntos por donde una clínica de salud pierde pacientes y dinero — y cómo taparlos en 5 días.

20 minutos de lectura · 5 días para arreglar la primera



Jose María Moscardó

Fundador, MOS Labs

mos-labs.com



CÓMO SE LEE ESTE DOCUMENTO

20 minutos. Una hoja con seis números al final.

INTRODUCCIÓN

Para qué sirve *este documento*

Esto no es una guía. Es una auditoría. Cuando termines de leerlo (20 minutos) tendrás una hoja con seis números que dicen, en euros, dónde se está yendo el dinero cada mes en tu clínica de salud.

A quién va dirigido: dueños y directores de clínicas privadas de podología, fisioterapia, oftalmología, medicina privada y nutrición (de 2 a 15 personas) que ya tienen pacientes, agenda viva y reputación local, pero sospechan que se les escapan tratamientos por procesos manuales, ausencias y falta de seguimiento. No aplica si todavía estás abriendo la primera consulta.

QUÉ TE LLEVAS

- Un marco para distinguir las seis fugas operativas más comunes en una clínica de salud privada española.
- Por cada fuga: cómo medirla con datos que ya tienes en tu agenda y software de gestión, en qué umbral debe preocuparte, una estimación de coste y la primera decisión que toca tomar.
- Una tabla de scoring para priorizar.
- Tres niveles de automatización (manual, asistida, autónoma) con cifras reales de inversión.
- Un plan de cinco días para arreglar la peor.

Lo que no te llevas: tutoriales paso a paso, comparativas exhaustivas de software sanitario, ni teoría sobre marketing sanitario.

MARCO

Qué es una "fuga" en una clínica de salud

Una fuga es un punto del proceso donde estás perdiendo facturación por inacción, no por incompetencia. Tres rasgos:

1. **Es invisible en la cuenta de resultados.** No aparece como un coste, aparece como un plan de tratamiento que no se cierra o un hueco de agenda que se queda parado.
2. **Es proporcional al volumen.** Cuantos más pacientes y más agenda tienes, más sangra.
3. **Tiene umbral.** Por debajo de cierto volumen no merece arreglarse; por encima, montar un sistema compensa al primer mes.

Las seis fugas que verás abajo aparecen sistemáticamente en clínicas privadas de podología, fisioterapia, oftalmología, medicina privada y nutrición. No están en orden de gravedad: están en orden cronológico dentro del recorrido del paciente.

Un dato para encuadrar la escala. El gasto sanitario privado en España alcanza ya los **34.056 millones de euros**, el 26% del total (IDIS, 2025). Y el tejido es de consulta pequeña: el **84% de las empresas del sector tiene 2 asalariados o menos** (INE, DIRCE 2024). En una clínica de este tamaño, con un ticket medio en el entorno de los **48 €**, no hace falta perder mucho cada día para que la suma del mes sea grave. Una sola fuga tapada paga el sistema entero. Dos al mes lo amortizan de sobra.

RECORRIDO DEL PACIENTE · 5 FUGAS DEL CICLO ASISTENCIAL



CICLO LARGO · FUGAS 5 Y 6 · LA BASE Y LA REPUTACIÓN



Las 4 fugas del recorrido del paciente + 2 propias del ciclo largo (la base inactiva y la reputación). Porcentajes sobre el total de la fuga mensual estimada.

CASO TRABAJADO

Clínica Salud Norte SL

Antes de entrar a las seis fugas, un ejemplo concreto. Clínica multidisciplinar privada (fisioterapia + podología + nutrición), 6 personas: 1 fundador-fisioterapeuta que dirige, 2 fisioterapeutas, 1 podólogo, 1 nutricionista a media jornada y 1 persona de recepción y agenda. Volumen de **~850 visitas/mes**. Ticket medio **~48 €**. Facturación **~480.000 €/año** (unos 40.000 €/mes). Caso ficticio, pero construido con cifras realistas del sector.

Auditoría rápida, hecha en una mañana mirando el software de gestión, la agenda y el registro de planes de tratamiento:

2 · Plan de tratamiento sin cerrar	3.800 €
1 · Consulta sin contestar	3.200 €
3 · Hueco por ausencia (no-show)	3.000 €
4 · Tratamiento a medias	2.400 €
5 · Paciente que no vuelve	1.500 €
6 · Reseña que nunca se pide	600 €

Total estimado

14.500 € / mes

Las fugas 1, 2 y 3 concentran el 69% del coste mensual: ahí está el Pareto. Anual: ~174.000 €.

Dos cosas que importan. Primero: el fundador llevaba meses sin tocar nada y estimaba "que se perdía algún paciente". Catorce mil quinientos al mes son **174.000 € al año** — alrededor del 36% de la facturación potencial, el equivalente a un fisioterapeuta a jornada completa más media plaza de recepción. Segundo: tres fugas concentran cerca de dos tercios del coste. Esa es la cola de Pareto que el resto del documento sirve para identificar en tu caso. (Ojo: las fugas pueden solaparse, así que el total es una estimación de techo, no una suma contable exacta.)

FUGA 1 · CONSULTA SIN CONTESTAR

El paciente que pide cita consulta a 2-3 clínicas en paralelo. Gana la primera que responde.

Consulta *sin contestar*

COSTE ESTIMADO

3.200 €/mes

SÍNTOMA

Te llaman, te escriben por WhatsApp, te dejan un formulario en la web o un mensaje en Doctoralia pidiendo cita. Si nadie contesta en minutos —recepción con un paciente, horario partido, hora de comer— ese paciente llama a la siguiente clínica. No es que no haya demanda: es que se enfría antes de que la atiendas.

CÓMO MEDIRLA CON DATOS QUE YA TIENES

- Cuenta las llamadas perdidas del mes en la centralita, más los formularios web y los mensajes de Doctoralia y WhatsApp sin responder en menos de una hora.
- Calcula el % de **primeras consultas sin contestar en menos de 1 hora**. Ese es tu número.
- Si tu software no lo registra, exporta los avisos de Doctoralia y el correo de recepción y crúzalos. Una hora de trabajo.

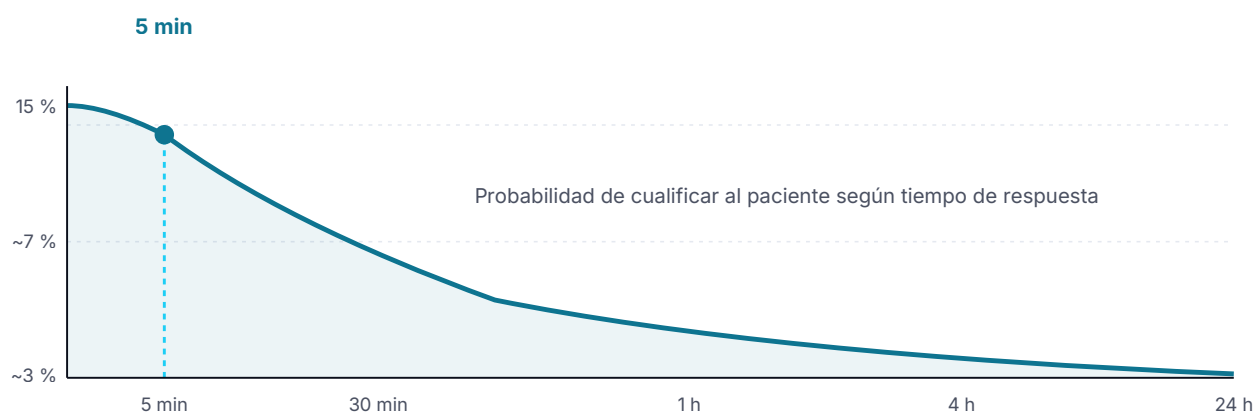
UMBRAL

Si más del **20% de las primeras consultas** se queda sin contestar en menos de 1 hora, estás en rojo. Si las consultas de viernes por la tarde y sábado esperan al lunes, fuga grave: una parte importante del paciente nuevo llega fuera de horario y no espera.

CUÁNTO TE CUESTA

Los datos son contundentes desde hace casi 20 años. El estudio del MIT Lead Response Management (Dr. James Oldroyd, replicado por Harvard Business Review) muestra que contactar a alguien en los primeros 5 minutos multiplica por **21 la probabilidad de cualificarlo** frente a hacerlo a los 30 minutos. En sanidad privada, donde el paciente consulta a 2-3 clínicas a la vez, esa ventana decide quién se queda la cita.

Cálculo del caso: la clínica recibe unas **120 consultas nuevas/mes**. Un 25% se queda sin respuesta a tiempo = 30 consultas. De esas se pierden unos **12 pacientes** que se van a otra clínica. Cada uno vale en torno a **267 €** en su primer episodio (primera visita + tratamiento inicial): $12 \times 267 \text{ €} = 3.200 \text{ €/mes}$.



Después del minuto 5, cada hora que pasa cuesta pacientes. La curva no es lineal: es exponencial. Fuente: MIT Lead Response Management Study (Oldroyd).

Y cada uno de esos pacientes no vale solo su primera visita: si entra en un bono de sesiones, en un programa o en revisiones, su valor a lo largo del tiempo es varias veces mayor. Tapar esta fuga es lo más barato y lo más rentable de todo el documento.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién responde cuando recepción está ocupada con un paciente? Tiene que haber un plan B, no el buzón de voz.
- ¿Hay una autorespuesta en menos de 2 minutos en WhatsApp y en la web que diga "te hemos leído, te llamamos en breve"?
- ¿El lead de Doctoralia entra en vuestro sistema o se queda muerto dentro de la app esperando a que alguien la abra?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Autorespuesta inmediata por WhatsApp Business o en la web en cuanto entra la consulta, en el mismo canal donde entró.
- Cola de devolución de llamada para que recepción la atienda en orden, sin que se pierda ninguna.
- Bandeja única que capte todos los canales (llamada, WhatsApp, web, Doctoralia) en un solo sitio, no cinco apps abiertas.



Lo que ve la paciente en WhatsApp tras consultar en Doctoralia a las 21:48, y el sistema que lo sostiene. La autorespuesta gestiona la cita; el criterio clínico siempre lo pone el profesional.

EL DATO

Contactar a un paciente en los primeros **5 minutos multiplica por 21 la probabilidad de cualificarlo** frente a hacerlo a los 30 (MIT Lead Response Management, Dr. James Oldroyd). En una clínica de salud, donde la persona consulta a varias clínicas a la vez, esa diferencia es directamente quién se queda la cita.

FUGA 2 · CONVERSIÓN

Plan de tratamiento *sin cerrar*

COSTE ESTIMADO

3.800 €/mes

SÍNTOMA

El paciente viene a primera visita, le propones un plan (un bono de sesiones, unas plantillas, un programa nutricional, una cirugía) y dice "me lo pienso". Nadie hace seguimiento. A los 10 días el plan está frío y el paciente, con dudas o ya en otra clínica.

CÓMO MEDIRLA

- De las primeras visitas con plan propuesto en el mes, cuenta cuántas acaban en **plan aceptado en 7 días o menos**.
- Ese porcentaje es tu **tasa de cierre**. Es el número que mejor predice si tu clínica crece o solo gira.

UMBRAL

Si cierras **menos del 50%** de los planes que propones, estás en rojo. No es un problema de precio ni de producto: es un problema de seguimiento.

CUÁNTO TE CUESTA

La clínica propone unos **150 planes/mes**. Un 40% no cierra = 60 planes. Con un seguimiento estructurado se recupera en torno al 25% = **15 planes**. A un ticket medio de plan de ~253 €: $15 \times 253 \text{ €} = 3.800 \text{ €/mes}$. Es la fuga más cara del caso, y la que peor se ve, porque no deja rastro: el plan simplemente se enfría.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Quién hace el seguimiento de un plan no cerrado, y cuándo? ¿A las 48 horas? ¿A los 7 días?
- ¿Tienes una secuencia definida o lo dejas al "ya llamarán ellos"?
- ¿El paciente se va de la primera visita con el plan y su importe por escrito, o solo con un "piénsatelo"?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Recordatorio automático al paciente con el plan y su importe a la vista, no un mensaje genérico.
- Tarea de seguimiento al equipo a las **48 horas** y a los **7 días** si el plan sigue sin cerrar.
- El plan visible en un único sitio para que recepción y profesional sepan en qué estado está cada propuesta abierta.

Plan propuesto · María L. · Fisioterapia
BONO 8 SESIONES FISIO + PLANTILLAS · PRESENTADO HOY EN PRIMERA VISITA · SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO

Importe del plan 420 € 8 sesiones + plantillas	Financiación 3m 140 €/m sin intereses	Estado Abierto "me lo pienso"	Prob. de cierre 70 % con seguimiento a 48h
---	--	--	---

Secuencia automática de seguimiento próximo: +48h (recordatorio) → +7 días (llamada del fisio)

Día 0 - plan enviado por WhatsApp >

Recomendación automatizada
El plan tiene importe asumible y financiación. La mayoría de cierres llegan tras el 2º-4º contacto, no en la primera visita: recordatorio a las 48h con el plan a la vista y llamada del fisio al día 7.

Lo que ve el profesional en su panel: el plan abierto, su importe, su financiación y el próximo toque ya programado. Sin perder mentalmente el hilo de los planes que quedaron en "me lo pienso".

LA REGLA DEL SEGUIMIENTO

La mayoría de los cierres no llegan en la primera visita: llegan **tras el segundo, tercer o cuarto contacto**. Si tu clínica solo hace el primer intento (el del día de la visita) y nadie vuelve a tocar el plan, estás dejando la mayor parte del cierre encima de la mesa.

FUGA 3 · AGENDA

Hueco *por ausencia (no-show)*

COSTE ESTIMADO

3.000 €/mes

SÍNTOMA

El paciente no aparece y nadie reconfirmó la cita la víspera. Queda un hueco en la agenda que no se rellena: el profesional parado y, en lista de espera, un paciente que podría haber entrado en ese hueco. Pierdes dos veces: el que no vino y el que sí habría venido.

CÓMO MEDIRLA

- Divide las ausencias del mes entre las citas totales del mes. Eso es tu **tasa de no-show**. Es el dato más fácil de sacar del software y el más doloroso de mirar.
- Mira específicamente los lunes por la mañana, viernes por la tarde y el día después de un puente: ahí la ausencia suele dispararse.

UMBRAL

Si tu tasa de no-show supera el **12%**, estás en rojo. La media en atención especializada en España está en el **14,6%** (Journal of Healthcare Quality Research). Las clínicas que automatizan recordatorios con confirmación activa lo bajan a la mitad en los primeros meses.

CUÁNTO TE CUESTA

Es la fuga más fácil de cuantificar. La clínica del caso tiene **850 citas/mes**. Con un no-show del **14,6%** son 124 ausencias. Un recordatorio que reconfirma evita aproximadamente la mitad = **62 huecos recuperados**. A un valor medio de hueco de **48 €**: $62 \times 48 \text{ €} = 3.000 \text{ €/mes}$. Las ausencias llegan a costar hasta 7.500 €/mes a clínicas privadas (El Independiente, 2025).

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Reconfirmas la víspera, o das la cita por buena hasta que el paciente no aparece?

- ¿Por qué canal recuerdas? WhatsApp tiene ~98% de apertura frente al ~20% del email. Para gestión de cita, **WhatsApp gana**.
- ¿Tienes lista de espera para rellenar el hueco en cuanto alguien cancela, o ese hueco se queda muerto?

CADENCIA DE RECORDATORIOS CON CONFIRMACIÓN ACTIVA



MOMENTO	CANAL	MENSAJE
Reserva	WhatsApp (auto)	Confirmación de cita + datos (fecha, hora, profesional) + dirección + cómo llegar.
T-7 días	WhatsApp	"Hola [nombre], te recordamos que tienes cita el [día] a las [hora]. Si necesitas cambiarla, contesta a este mensaje."
T-1 día	WhatsApp con botones	"Mañana a las [hora]. ¿Confirmas asistencia?" — botones: ✓ CONFIRMO · CANCELAR · REAGENDAR.
T-2h	WhatsApp / SMS	Solo si no ha confirmado. "Tu cita es hoy en 2 horas. ¿Vienes?". Si cancela, el hueco se libera automáticamente.
Cita	Software	Si confirmó, llega. Si canceló, el sistema avisa al siguiente paciente de lista de espera para llenar el hueco.

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Recordatorio automático por WhatsApp 24h antes con **botón de confirmar/cancelar en un clic** (no solo un aviso pasivo).
- Si el paciente no confirma, segundo recordatorio T-2h con confirmación activa.
- Si cancela o reagenda, el hueco se libera automáticamente y entra en **lista de espera** — el sistema avisa al siguiente paciente que pedía esa franja.
- Para tratamientos con preparación (algunas pruebas, ciertas exploraciones), recordatorio adicional con las instrucciones que indique el profesional.

EL DATO

Las ausencias cuestan hasta **7.500 €/mes** a clínicas privadas (El Independiente, 2025). Y el canal importa: WhatsApp tiene cerca del **98% de apertura** frente al ~20% del email. Un recordatorio con confirmar/cancelar en un clic la víspera es lo que más mueve la aguja.

FUGA 4 · TRATAMIENTO A MEDIAS

La adherencia en fisioterapia cae hasta el 70% cuando el programa no se supervisa.

Tratamiento *a medias* (abandono)

COSTE ESTIMADO

2.400 €/mes

SÍNTOMA

El paciente empieza un tratamiento de varias sesiones (rehabilitación, podología, un programa nutricional) y lo deja a la mitad. No solo pierdes las sesiones que faltan: el resultado clínico empeora y, con él, la recomendación y la reseña. Un abandono es una fuga doble: ingreso y reputación.

CÓMO MEDIRLA

- Calcula el **% de tratamientos iniciados que no se completan** en el plazo previsto.
- Cruza la lista de tratamientos multisesión abiertos con la última cita de cada paciente: el que lleva semanas sin volver y aún tiene sesiones pendientes es un abandono en curso.

UMBRAL

Si tu tasa de abandono supera el **30%**, estás en rojo. En fisioterapia, la adherencia cae hasta el **70%** en programas no supervisados (revisión Physiotutors): sin un sistema que detecte el abandono, tres de cada diez pautas se quedan a medio camino.

CUÁNTO TE CUESTA

La clínica del caso tiene unos **80 tratamientos multisesión activos/mes**. Con un abandono del **30%** son 24 tratamientos que se cortan. Con una media de **2 sesiones no realizadas** por abandono a **50 €/sesión**: $24 \times 2 \times 50 \text{ €} = 2.400 \text{ €/mes}$. Y eso sin contar el coste reputacional del paciente que no termina y no recomienda.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Detectas cuándo un paciente deja de venir a media pauta, o te enteras cuando revisas la agenda dentro de un mes?
- ¿Alguien le escribe para recuperarlo, o se da por perdido sin más?
- ¿Mides la adherencia como un indicador, o no la mides en absoluto?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Alerta automática cuando un paciente con tratamiento abierto lleva **X días sin cita** teniendo sesiones pendientes.
- Mensaje de recuperación que el profesional aprueba antes de enviar, no automático a ciegas.
- Un panel de tratamientos abiertos con su grado de avance, para que el equipo vea de un vistazo quién se está descolgando.

Panel de adherencia · tratamientos multisesión abiertos

hecha

pendiente

perdida

A. Gómez · rehabilitación hombro última cita: hace 4 días	1 2 3 4 5 6	al día
M. Torres · programa nutricional última cita: hace 24 días · 3 pendientes	1 2 3 4 5 6	ABANDONO
J. Pérez · rehabilitación rodilla última cita: hace 12 días · 2 pendientes	1 2 3 4 5 6	EN RIESGO

Acción que dispara el sistema
M. Torres lleva 24 días sin volver con 3 sesiones pendientes → mensaje de recuperación a la cola del profesional.

El sistema no decide el tratamiento: solo detecta quién se está descolgando de su pauta y lo pone delante del profesional para que actúe a tiempo.

EL DATO

En fisioterapia, la adherencia cae hasta el **70% en programas no supervisados** (revisión Physiotutors). Dicho de otro modo: sin un sistema que avise cuando un paciente deja de venir, una parte grande de tus pautas se queda a medias y con ella el resultado clínico que sostiene tu reputación.

Paciente *que no vuelve*

COSTE ESTIMADO

1.500 €/mes

SÍNTOMA

Pacientes que trataste y a los que nadie recuerda la revisión: el control podológico, la revisión oftalmológica anual, el chequeo, el mantenimiento. No se van enfadados. Simplemente nadie les da un motivo para volver, y la próxima vez que lo necesiten buscan en Google y aparece otra clínica.

CÓMO MEDIRLA

- Calcula el **% de la cartera activa hace 12-24 meses que no ha vuelto**. Esa es tu cartera dormida.
- Mira también el ratio "ingreso de pacientes que repiten / ingreso total". Si es bajo, dependes demasiado de captar paciente nuevo cada mes.

UMBRAL

Si más del **40% de tu cartera está inactiva y nadie la reactiva**, estás en rojo. No tienes un problema de captación: tienes un problema de recurrencia. Reactivar a quien ya te conoce es mucho más barato que traer a alguien nuevo.

CUÁNTO TE CUESTA

La clínica del caso tiene una base de **~3.000 pacientes**. Reactivar solo el **1% al mes** con un recordatorio de revisión son 30 pacientes. A un ticket medio de **50 €**: $30 \times 50 \text{ €} = 1.500 \text{ €/mes}$. Es una cifra conservadora: un solo recordatorio de revisión bien segmentado suele dar más.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Tienes ciclos de revisión definidos por tipo de paciente (control podológico, revisión anual, mantenimiento), o no los convoca nadie?
- ¿Alguien los dispara, o dependen de que el paciente se acuerde solo?
- ¿Segmentas por fecha de última visita y tipo de tratamiento, o tratas a toda la base igual?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Recordatorio automático de revisión según el **tipo de tratamiento y la fecha de la última visita**: cada paciente recibe el suyo cuando le toca, no un envío genérico.
- Segmentación por última visita para no escribir a quien acaba de venir ni saturar a la base.
- Enlace directo a reservar en agenda online, para que volver sea un clic y no una llamada.



Motor de reactivación: cada paciente se cruza con el calendario de oportunidades (clínicas, estacionales, personales). Sin spam y segmentado: máximo unos pocos contactos al año por paciente.

EL DATO

Captar un paciente nuevo cuesta **5-7 veces más** que reactivar a uno que ya te conoce. La cartera dormida es el activo más barato que tienes: el paciente ya confía en ti, solo necesita un motivo y un recordatorio para volver.

Reseña *que nunca se pide*

COSTE ESTIMADO

600 €/mes (estimación)

SÍNTOMA

Pacientes contentos que se van sin que nadie les pida una reseña. Mientras tanto, el paciente que duda entre tu clínica y la de al lado decide por las estrellas de Google. Tienes el resultado clínico y la satisfacción; lo que no tienes es la prueba pública que convence al siguiente.

CÓMO MEDIRLA

- Cuenta tus **reseñas nuevas al mes** frente a los pacientes atendidos al mes. La distancia entre esos dos números es la fuga.
- Mira tu nota media y el número total de reseñas frente a la clínica que tienes al lado en Google.

UMBRAL

Con tu volumen de pacientes, **menos de 5 reseñas nuevas al mes** es rojo. No porque falten pacientes satisfechos, sino porque no se las estás pidiendo de forma sistemática.

CUÁNTO TE CUESTA

Aquí la cifra es una **estimación sectorial conservadora**: ~600 €/mes de captación perdida. El **87% de las personas lee reseñas antes de elegir un negocio local** (BrightLocal), y subir de nota y volumen de reseñas mueve el flujo de pacientes nuevos un **+4-8%**. En una clínica que factura ~40.000 €/mes, ese porcentaje de captación adicional supera con holgura los 600 € que aquí contabilizamos. Lo marcamos como estimación a propósito: el resto de fugas son cálculos directos; esta es un orden de magnitud.

DECISIÓN QUE TOCA

- ¿Pides reseña de forma sistemática tras el alta, o solo cuando te acuerdas?
- ¿A quién se la pides y cuándo? ¿Al cerrar un tratamiento con buen resultado, o a todo el mundo sin criterio?
- ¿Lo automatizas sin ser invasivo, o no hay ningún proceso y depende de que recepción se acuerde?

LO MÍNIMO QUE DEBE HACER EL SISTEMA

- Mensaje automático de petición de reseña **al cerrar un tratamiento con buen resultado**, con enlace directo a Google.
- Sin disparar a quien no ha terminado o no quedó satisfecho: la petición se segmenta, no se manda a ciegas.
- Una vía de baja clara y respeto al ritmo del paciente, para no quemar la relación.



El 87% de las personas lee reseñas antes de elegir un negocio local. La reputación no se improvisa: se pide, en el momento justo.

De alta satisfecha a reseña publicada, sin que recepción tenga que acordarse. La petición se dispara sola al cerrar un buen resultado y respeta al paciente que no quiere.

EL DATO

El **87% de las personas lee reseñas online antes de elegir un negocio local** (BrightLocal). En salud, donde la decisión es delicada y la confianza lo es todo, esa cifra pesa todavía más: las estrellas de Google son, para muchos pacientes, la primera consulta.

Tabla de *scoring*

Dos pasos. Primero, marca tu situación de 0 a 3 en cada fuga:

- **0:** la fuga no aplica a mi negocio.
- **1:** ya está resuelta (sistema en marcha y monitorizado).
- **2:** la sospecho pero no la he medido.
- **3:** la tengo, la veo, no he hecho nada.

Segundo, calcula el coste estimado con la fórmula correspondiente. **No estimes al ojo:** pon números reales (los tuyos, sacados del software de gestión y de la agenda).

FÓRMULAS DE COSTE MENSUAL

FUGA	CÓMO SE MIDE	UMBRAL · VERDE / AMARILLO / ROJO	COSTE DEL CASO
1 · Consulta sin contestar	% 1ª consultas sin contestar <1h	<10% / 10-20% / >20%	3.200 €/mes
2 · Plan sin cerrar	% planes cerrados ≤7 días	>65% / 50-65% / <50%	3.800 €/mes
3 · Hueco por ausencia	ausencias ÷ citas totales	<8% / 8-12% / >12%	3.000 €/mes
4 · Tratamiento a medias	% tratamientos no completados	<20% / 20-30% / >30%	2.400 €/mes
5 · Paciente que no vuelve	% cartera inactiva sin reactivar	<25% / 25-40% / >40%	1.500 €/mes
6 · Reseña que nunca se pide	reseñas nuevas/mes vs pacientes	>10 / 5-10 / <5	600 €/mes

Notas. Los umbrales son orientativos para una clínica privada pequeña; ajústalos a tu volumen y tu mezcla de servicios. El "coste del caso" es el de Clínica Salud Norte SL (~850 visitas/mes, ticket ~48 €): tus cifras serán distintas, lo que no cambia es el método de cálculo de cada fuga. El coste de la fuga 6 es una estimación sectorial, no un cálculo directo como las demás.

TU TABLA

FUGA	MI PUNTUACIÓN (0-3)	COSTE ESTIMADO / MES
1 · Consulta sin contestar	—	— €
2 · Plan de tratamiento sin cerrar	—	— €
3 · Hueco por ausencia (no-show)	—	— €
4 · Tratamiento a medias	—	— €
5 · Paciente que no vuelve	—	— €

FUGA	MI PUNTUACIÓN (0-3)	COSTE ESTIMADO / MES
6 · Reseña que nunca se pide	—	— €
Total estimado		— € / mes

Regla práctica: prioriza arreglar la fuga con mayor coste estimado/mes que esté en puntuación 2 o 3. No la más fácil. La más cara. En una clínica de salud, casi siempre es la fuga 2 (planes sin cerrar) o la fuga 1 (consultas sin contestar).



SOLUCIÓN

3 niveles de *automatización*

Una vez tienes el diagnóstico, viene la pregunta: ¿cuánto cuesta arreglar esto? Piénsalo en tres niveles de madurez. No son productos cerrados: son etapas. Se empieza por la **manual**, se sube a la **asistida** cuando el volumen lo pide, y se llega a la **autónoma** cuando los procesos ya están ordenados.



De manual a autónoma. Cada nivel se apoya en el anterior: primero ordenas el proceso, luego el sistema asiste, y al final segmenta y actúa solo sobre las fugas de ciclo largo.

Cuándo tiene sentido cada uno. Manual: siempre, es el punto de partida de cualquier clínica que quiera medir antes de invertir. Asistida: en cuanto el volumen de consultas y citas hace inviable que recepción lo sostenga a mano (a partir de unos cientos de visitas al mes). Autónoma: cuando los procesos ya están ordenados y tienes una base de pacientes lo bastante grande como para que segmentar marque la diferencia.

La automatización siempre vive encima del flujo, no decide el tratamiento. Las herramientas de terceros (WhatsApp Business API con coste variable por conversación, agenda, email) se facturan aparte de los honorarios de implantación. Lo importante no es el nivel en el que estás, sino no saltarte el primero.

Una nota sobre el software de gestión

La pregunta más común: "¿me sirve mi software actual o tengo que cambiarlo?". Respuesta corta: **casi nunca hay que cambiarlo**. La automatización vive encima de tu software de gestión sanitario conectándose a su API o vía sincronización. Lo único realmente necesario es que tu plan permita acceso a la API o a integraciones, y que cualquier dato clínico se trate en software sanitario conforme, con su contrato de encargo de tratamiento.

Si te planteas cambiar de software, el criterio no es la marca: es que tenga **agenda online, recordatorios y API abierta**, y que cumpla con la normativa de protección de datos de salud. Esa es la base sobre la que se monta todo lo demás.

ANTI-PATRONES

Qué *no* automatizar

Esto es tan importante como las seis fugas. Automatizar el sitio equivocado convierte un proceso lento en un proceso roto y rápido. Y en salud, donde manejas datos de categoría especial, equivocarse tiene consecuencias legales, no solo comerciales.

✗ No envíes resultados ni diagnósticos por WhatsApp

Los datos de salud son **categoría especial** (art. 9 del RGPD). WhatsApp vale para la **gestión de la cita** (recordar, confirmar, reagendar), nunca para enviar resultados, informes o información clínica. Para eso, canal seguro y consentimiento, según el criterio de la AEPD.

✗ No metas datos clínicos en herramientas genéricas sin contrato

Una hoja de cálculo cualquiera o un CRM genérico no sirven para datos de salud sin un **contrato de encargo de tratamiento** con el proveedor. Usa software sanitario conforme, que es donde deben vivir los datos clínicos.

✗ No automatices sin una vía de baja clara

Toda comunicación automatizada necesita una **vía de baja sencilla** y que el paciente haya sido informado de para qué usas sus datos. Recordatorios y reactivaciones sin opción de darse de baja no son solo molestos: son un problema legal.

✗ No sustituyas el criterio clínico por una regla automática

La automatización **gestiona el flujo, no decide el tratamiento**. Avisa, recuerda, prepara, segmenta. Quién se trata, cómo y cuándo, lo decide siempre el profesional cara a cara con el paciente.

✗ No dispares recordatorios genéricos a toda la base

Segmenta por **tipo de tratamiento y fecha de última visita**. Mandar el mismo mensaje a los 3.000 pacientes a la vez quema la lista: la gente se da de baja, marca como spam y deja de leerte justo cuando más lo necesitas.

✗ No automatices procesos que aún no entiendes a mano

Si no puedes describir paso a paso cómo contesta recepción, qué hace cuando un paciente cancela o cómo se decide la pauta de seguimiento, no lo automatices. Primero ordénalo en papel; el sistema solo amplifica lo que ya existe.

Si lees este apartado y piensas "es de sentido común", correcto. Pero la mayoría de los proyectos de automatización que fracasan en clínicas de salud fracasan exactamente aquí: o por saltarse el orden, o por descuidar la protección de los datos del paciente.

PLAN DE ACCIÓN

Cinco días, papel y boli. La auditoría se cobra al cuarto.

ACCIÓN

Qué hacer mañana

Asumiendo que has identificado tu fuga prioritaria, un plan de cinco días.



DÍA 1 · 1 HORA

Mide

Saca el dato real, no la sensación. Calcula tu **tasa de no-show** (ausencias ÷ citas) de los últimos 3 meses, tu **% de primeras consultas sin contestar en menos de 1 hora** y cuántas **reseñas nuevas** recibiste el último mes. Tres números, una hora.

DÍA 2 · 2 HORAS

Decide

Elige las **dos fugas más caras** de tu tabla de scoring y responde por escrito a las 2-3 preguntas de "decisión que toca" de cada una. No avances sin estas respuestas. Cualquier herramienta sin esto resuelto es dinero tirado.

DÍA 3 · 2-3 HORAS

Diseña el flujo en papel

Literalmente, papel y boli. Qué dispara qué, en qué canal, con qué mensaje, con qué condiciones de salida. Si no cabe en una hoja, está sobreingenierizado.

DÍA 4 · MEDIO DÍA

Lleva el flujo al sistema

Empieza por lo que más mueve la aguja: **recordatorios de cita** con confirmación y **seguimiento de planes** a las 48h. Si es simple, tu software de gestión lo hace. Si es complejo (WhatsApp Business API + agenda + tareas de equipo), valora montarlo internamente, subcontractarlo o usar plataformas como n8n o Make, siempre con software sanitario conforme para el dato clínico.

DÍA 5 · 1 HORA

Define cómo medirás que funciona

Métrica concreta, periodicidad, umbral de éxito. Sugerencias: para la fuga 1, % de consultas contestadas en menos de 1 hora; para la fuga 2, tasa de cierre de planes; para la fuga 3, tasa de no-show mensual.

A los 30 días, revisa el dato. A los 90 días, decide si escalar a la siguiente fuga.

Fuentes: IDIS, Observatorio de la Sanidad Privada 2025 — gasto sanitario privado 34.056 M€, 26% del total (fundacionidis.com); INE, DIRCE 2024 — 84% de empresas del sector con ≤2 asalariados (ine.es); Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas — 74.990 colegiados en 2025 (consejo-fisioterapia.org); Journal of Healthcare Quality Research / Elsevier — no-show del 14,6% en atención especializada (elsevier.es); El Independiente, 2025 — las ausencias cuestan hasta 7.500 €/mes a clínicas privadas; Physiotutors — la adherencia en fisioterapia cae hasta el 70%; BrightLocal / COMSalud — el 87% lee reseñas antes de elegir, impacto de la nota +4-8% de volumen; AEPD — datos de salud, categoría especial del art. 9 RGPD; WhatsApp solo para gestión de citas (aepd.es); AEAT — IVA exento en asistencia sanitaria, art. 20.Uno.3º Ley 37/1992, con fin médico no estético; MIT Lead Response Management Study (Dr. James Oldroyd) — responder en 5 minutos multiplica ×21 la cualificación; Meta / WhatsApp — apertura de mensajes ≈98%.



SIGUIENTE PASO

¿Cuántas de estas seis fugas tienes abiertas ahora mismo en tu clínica?

Un diagnóstico de 30 minutos. Sin compromiso. Sales con tus tres prioridades y, si encajamos, una propuesta a la semana.

Agendar diagnóstico de 30 minutos →

moslabs.zohobookings.eu/#/moslabs



Jose María Moscardó

Más de 8 años en marketing B2B (CHEP, Nielsen, OpenUp). Fundé MOS Labs para resolver exactamente este tipo de fugas en PYMEs españolas — con foco en clínicas de salud: podología, fisioterapia, oftalmología, medicina privada y nutrición — usando automatización inteligente y consultoría de procesos.